

Practica 3 - Caso Consultorio Dental



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

ADE

Facultad de Administración
y Dirección de Empresas /UPV

Francisco Javier Checa Casas

Cesar Deusa De Lamo

Marc Ferri Saez

Pregunta 1:

1. **Producto:** El servicio central es la atención dental de calidad, con procedimientos estandarizados, tecnología y formación continua del equipo.
2. **Precio:** La doctora fija precios superiores al mercado, rechazando los límites de las OMS. Los pacientes asumen copagos que su seguro no cubre, justificados por la calidad diferencial. El precio actúa aquí como señal de calidad.
3. **Distribución:** Construcción de un edificio propio diseñado con diseño escandinavo, luz natural y espacios amplios. La ubicación y el entorno físico son en sí mismos parte del servicio.
4. **Publicidad:** No hay publicidad tradicional. El canal exclusivo es el boca a boca. Esto refuerza la credibilidad del servicio ya que los nuevos pacientes llegan con expectativas ya positivas.
5. **Personas:** El elemento más trabajado. La doctora afirma que el 90% de la percepción de calidad proviene de la interacción con el personal, no de las habilidades técnicas. Hay selección cuidadosa, formación continua, reuniones periódicas, bonos por rendimiento y viajes anuales de equipo como incentivo.
6. **Procesos:** Todos los sistemas fueron rediseñados con ayuda de un consultor, tiempos asignados por procedimiento, política de espera máxima de 20 minutos, llamadas preventivas ante retrasos, gestión activa de cancelaciones y reuniones de mejora continua.
7. **Entorno físico:** Muy desarrollado. Muebles modernos, música clásica, arte en paredes, etc. Todo comunica calidad y cuidado.
8. **Productividad y Calidad:** El detonante del cambio. La mudanza buscaba precisamente mejorar eficiencia sin sacrificar calidad. Se estandarizan rutinas para reducir errores y garantizar uniformidad en la atención. Los bonos ligados a resultados financieros alinean al equipo con este objetivo.

Pregunta 2:

Las visitas al dentista generan lo que en marketing de servicios se denomina ansiedad previa al consumo, potenciada por varios factores:

1. Dolor anticipado: los procedimientos dentales son intrínsecamente incómodos o dolorosos.
2. Ruidos y olores asociados a experiencias previas negativas.
3. Coste elevado que no siempre está cubierto por el seguro, lo que añade estrés económico.
4. Culpa percibida por el estado de la salud dental propia.

La doctora lo aborda mediante:

1. El entorno (música, arte) reduce la ansiedad sensorial y distrae al paciente.

2. Los cascos con música y las almohadas aumentan el confort.
3. Las películas educativas y la literatura informativa reducen la incertidumbre, que es una de las principales fuentes de ansiedad.
4. Las llamadas de seguimiento postratamiento generan confianza y vínculo emocional.
5. La actitud del personal, entrenado para ser empático y cercano, neutraliza la actitud negativa inicial.

Sin embargo, el caso reconoce que algunos pacientes expresan aversión incluso antes de sentarse en el sillón. La doctora lo gestiona con resiliencia profesional.

Pregunta 3:

Lo que hacen actualmente:

- Examen inicial obligatorio para todos los pacientes nuevos: sirve para evaluar necesidades y explicar la filosofía de la clínica. Es el primer punto de diferenciación percibida.
- Sala con vídeos educativos sobre procedimientos dentales.
- Literatura informativa para que los pacientes comprendan cómo optimizar los beneficios de sus tratamientos.
- Declaración de misión visible en la sala de espera, que comunica los valores del equipo.
- Fotografías del personal y sus familias que humanizan la relación y reducen la distancia psicológica.

Qué más podrían hacer:

- Newsletter o comunicación periódica con consejos de salud dental, novedades de la clínica y recordatorios de revisión. Mantiene la relación.
- Testimonios de pacientes en la sala de espera o en un posible sitio web, que actúen como prueba social.
- Explicación activa durante el procedimiento: el profesional puede ir describiendo lo que hace paso a paso, lo que reduce la sensación de pérdida de control.
- Presencia digital básica: aunque no haga publicidad pagada, una web o perfil Google con reseñas verificadas reforzaría la credibilidad ante pacientes que la buscan antes de ir.

Pregunta 4:

Ofrecen servicios complementarios como café, té, revistas, kits dentales y llamadas de seguimiento. También incluyen comodidades físicas como almohadas y entretenimiento.

En conjunto, estos servicios complementarios transforman una experiencia potencialmente negativa en una positiva, y son precisamente los que los pacientes perciben y recuerdan, justificando los precios premium frente a proveedores de menor coste.

Pregunta 5:

En la mayoría de las consultas convencionales, el entorno es clínico y frío, los tiempos de espera no se gestionan activamente, no existe seguimiento postratamiento y la comunicación con el paciente es mínima. La visita es puramente transaccional.

La doctora Beckett, en cambio, ha diseñado una experiencia de servicio completa, donde cada elemento responde a una decisión consciente orientada a la calidad percibida.

- a. El mayor error de las consultas tradicionales es asumir que la calidad técnica es suficiente. En los servicios, los pacientes rara vez pueden evaluar la calidad técnica, pero sí evalúan con precisión cómo los trataron, cuánto esperaron y cómo se sintieron. Por tanto, invertir en la experiencia del paciente tiene un retorno directo en fidelización y recomendaciones, que son el canal de captación más eficiente y económico en este sector.
- b. Su principal vulnerabilidad es la dependencia de una sola dentista. Todo el sistema gira en torno a ella, lo que limita la capacidad y crea un riesgo operativo alto. Además, la dificultad de demostrar la calidad antes de la primera visita podría resolverse con una presencia en las redes sociales sólida, no con publicidad agresiva, sino reseñas y una web que transmita la misma filosofía que vive el paciente al entrar a la clínica.